

主诉表1 | 主诉入口标准化表（每个主诉1行）

字段（中文）	填写内容	示例
主诉编号	主诉唯一标识	CC_001
主诉标准名（中文）	标准主诉名称	水肿
主诉定义	一句话定义“用户在抱怨什么”，不写诊断	组织间液体增多导致的肿胀表现
包含范围	条目化（3-8条）	下肢肿胀；眼睑肿胀；手足肿胀
排除范围	条目化（3-8条）	局部肿块；明确外伤后的局部肿痛；单纯体重增加无肿胀
适用人群	成人/儿科/孕产等（可多选）	成人；孕产
适用场景	全科/急诊/专科/健康管理等（可多选）	全科；急诊
默认入口方向	症状诊断/健康管理/混合	症状诊断
最小关键字段配置	引用主诉表2（不在本表展开）	见主诉表2
危险信号清单引用	引用规则层ID	RULE_RED_FLAG_XXX
收敛/停止条件引用	引用规则层ID	RULE_STOP_XXX
升级/转诊触发引用	引用规则层ID	RULE_ESCALATE_XXX
版本号/更新时间	便于迭代	v0.1 / 2026-01-28

主诉表2 | 最小关键字段配置表（字段细节在此；一行=1个信息点）

信息点	必填等级	标准问法（原话）	答案口径（简写）	缺失处理（简写）
起病时间与过程	必须	什么时候开始的？突然还是慢慢加重？	突然/渐进/不确定；时长数值+单位	必须补齐
部位/范围	必须	具体哪里不舒服？是一点还是一片？	标准部位；可多选；不确定	必须补齐
分布	必须	是一侧明显还是两侧差不多？	单侧/双侧/局部/不确定	必须补齐
性质	必须	更像刺痛、压着、灼烧还是闷胀？	固定词+不确定	必须补齐
严重度	必须	0到10分你给几分？	0-10/不确定（或轻中重统一一种）	必须补齐
诱因	重要	什么情况下出现或加重？	运动/进食/体位/情绪/外伤/不确定	可继续但降级
缓解因素	重要	休息/停下来/用药后会缓解吗？	有/无/不确定+简述	可继续但降级
伴随症状	重要	同时还有哪些不适？	3-5个标准症状+不确定	可继续但降级
关键背景	重要	有相关既往史/用药/妊娠/暴露吗？	有/无/不确定+简述	可继续但降级
危险信号自检	必须	有没有晕厥/大汗/明显呼吸困难等？	有/无/不确定	命中走兜底

主诉表3 | 主诉澄清规则表（候选主诉分叉最小问题集；一行=1条分叉规则）

触发情况（哪些主诉同时出现）	最小澄清问题（原话）	答案选项（含不确定）	判定结果（落到哪个主诉）	不确定兜底
例：胸闷 + 呼吸困难	你主要是不够气/喘不上来，还是胸口压闷为主？	不够气；压闷；两者都有；不确定	不够气→呼吸困难；压闷→胸闷；两者都有→并行保留	并行保留 + 先走危险信号兜底

主诉表4 | 鉴别诊断框架子类表（Step2 分组；一行=1个子类）

框架类型	子类名称	子类边界（一句话）	子类候选疾病集合（只写疾病名/ID列表）	must-not-miss（必须优先除外）	后续优先差异点（表7编号）
例：分布分叉	单侧	以单侧为主的表现	疾病A；疾病B；疾病C	疾病B	PP_01；PP_02

主诉表5 | 三层候选总览表（展示/对齐用；每个主诉1行）

Tier1 最可能	Tier2 必须优先除外	Tier3 积极备选	分层口径（一句话）
例：常见方向组A	例：高危不能漏组B	例：易混淆组C	Tier2按must-not-miss优先；Tier1按匹配度与阳性线索

主诉表6 | 候选疾病明细表（Step2 落地；一行=1条“疾病”）

疾病	默认层级	入选依据（1句）	当前支持线索（列标题即可）	当前反对线索（列标题即可）	下一步必须补齐的缺口（列标题即可）	首选获取方式（追问/检查）
疾病B	Tier2	漏诊后果严重且与现有表现相符	单侧；突发；高危背景	无发热	起病速度；疼痛强度	追问（必要时检查）

主诉表7 | 推理子组清单表（Step3；一行=1个“线索簇/推进组”）

子组名称	覆盖疾病 (列表)	子组进入触发 (线索标题)	推进目标 (一句话)	优先补齐缺口 (线索标题)	推进路径 (追问/ 检查/混合)
血栓风险线索组 (例)	疾病B；疾病D	单侧；突发；久坐卧	先把必须优先除外方向分流清楚	起病速度；疼痛；呼吸症状	混合

主诉表8 | 关键差异点配置表 (Step4；一行=1个差异点)

差异点名称	标准问法 (原话)	答案选项 (含不确定)	主要影响哪些 子组/疾病 (写名称)	动作 (前移/后移/ 保留/触发检查/触发升级)	阴性限制说明 (1句)	不确定处理 (1句)
单侧 vs 双侧 (例)	是一侧明显还是两侧差不多？	单侧；双侧；不确定	血栓风险组；回流受阻组	单侧→前移血栓风险；双侧→前移回流受阻	双侧不能直接排除血栓，仅后移	两组并行保留继续问下一差异点

主诉表9 | 检查/检验建议与结果解释 (主诉专属；一行=1个项目)

检查/检验项目	什么时候建议做 (触发点一句话)	目的 (支持/排除哪些方向)	关键结果怎么理解 (口径)	结果会影响什么 (子组/疾病)
心电图 (例)	Tier2方向被触发或症状持续加重时	支持/排除高危心源性方向	异常=支持线索；无明显异常=排除	上调/下调相关方向组

主诉表10 | 回填、重排、收敛触发点 (闭环清单；一行=1个触发场景)

触发情况 (发生了什么)	要做的动作 (更新/调整/输出/升级)	影响范围 (哪些子组/疾病)	引用规则层 (只写规则名/编号)
命中危险信号 (例)	立即中断常规问诊→安全兜底输出	所有候选整体上调	风险识别+安全兜底
关键反驳线索出现 (例)	下调或移出某方向/疾病	对应疾病	回填与重排
证据充分且收敛 (例)	输出结论包	最终1-2个方向	收敛停止